

01 - 01- Approche Palliative - Pr. HACHIMI

Bonjour, je suis Professeur Hashimi. Notre premier cours en soins palliatifs est l'approche palliative. Au nom de ce cours, nous allons définir les soins palliatifs, décrire les principes de l'approche palliative, puis on va identifier les patients qui sont candidats à l'approche palliative et ensuite décrire les phases de l'approche palliative et l'organisation et les structures des soins palliatifs.

D'une manière générale, les experts ont décrit les soins palliatifs comme ajouter de la vie à chaque jour quand on ne peut plus ajouter des jours à la vie ou tout ce qu'il reste à faire quand il n'y a plus rien à faire. L'Organisation mondiale de la santé a décrit les soins palliatifs comme l'ensemble des soins dispensés aux personnes atteintes d'une maladie avec un pronostic réservé qui vise à atténuer la douleur et les autres symptômes, y compris psychologiques, sociales et spirituelles. Le concept des soins palliatifs a été décrit déjà à l'ère d'Hippocrate qui a décrit les rôles des médecins, soulager, guérir quand c'est possible, assister, accompagner toujours et témoigner d'une véritable compassion.

Le premier hôpital de soins palliatifs a été bâti en 1907 à Londres et l'unité de soins palliatifs francophones en 1978 au Canada. Les soins palliatifs ont été reconnus comme spécialité en Angleterre en 1987, en Ouganda en 1993 et enfin en 2007 aux États-Unis. L'Organisation mondiale de la santé compte 40 millions de personnes qui ont besoin de soins palliatifs, dont 78 % sont dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires et malheureusement que 14 % de ces malades qui en bénéficient.

Le besoin en soins palliatifs est en nette augmentation vu le vieillissement des populations et l'accroissement des maladies non transmissibles. Les soins palliatifs ne visent ni à accélérer ni à repousser la mort. Considérez le malade comme un être vivant.

Considérez la mort comme un processus normal, naturel. Et tout ça dans un but d'améliorer la qualité de vie en soulageant la douleur et les autres symptômes, intégrer les aspects psychologiques et spirituels des patients et leurs proches, aider les patients à vivre aussi activement que possible, aider aussi la famille à tenir pendant la durée de la maladie et à bien vivre leur propre deuil, appliquer tout en association avec les traitements curatifs et tout ça dans une approche d'interdisciplinarité. L'interdisciplinarité est définie comme l'analyse et la synthèse de plusieurs disciplines en association leurs compétences et en harmonisant leur intervention vers un objectif commun qui est l'amélioration de la qualité de vie de ces malades.

Au contraire, la multidisciplinarité, c'est quand chaque spécialité concerne ses concepts et ses méthodes. Les principes des soins palliatifs concernent les trois piliers des soins palliatifs qui sont le patient, la famille et l'équipe soignante. Pour le patient, préserver sa dignité, respecter son choix et ses décisions en fonction de ses croyances et de ses volontés, préserver son confort, le prendre en charge dans sa globalité avec ses souffrances physiques, psychologiques, spirituelles

et sociales.

Pour la famille, communiquer et informer en continu, l'impliquer dans les décisions et les projets de soins, assurer l'accompagnement et le soutien psychologique, la préparer et la prendre en charge en ce qui concerne le deuil. Pour l'équipe soignante, travailler en interdisciplinarité, en assurant la continuité des soins et la préserver de l'épuisement professionnel. L'évolution de la maladie passe par deux phases, phase curative et phase palliative, qui se subdivisent en une phase initiale, avancée et terminale.

Les soins palliatifs ou les soins de support commencent dès l'annonce du diagnostic d'une maladie grave en association avec les soins ou les traitements spécifiques et curatifs et prend de l'ampleur jusqu'à l'arrêt des soins curatifs. Et ça continue jusqu'au décès. La prise en charge de la famille et de l'entourage commence aussi dès le diagnostic jusqu'au décès.

Pour la phase curative, l'objectif est la guérison. Pour la phase palliative initiale, l'objectif n'est plus la guérison, mais l'amélioration de la qualité de vie où on peut avoir recours à des traitements spécifiques tels que la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie pour ralentir la progression de la maladie. Pour la phase palliative avancée, l'objectif est le contrôle des symptômes.

Tous les traitements qui nuisent à la qualité de vie sont arrêtés. Pour la phase palliative terminale, quand le décès est prévu dans les jours ou semaines à venir, les symptômes sont traités d'une façon individuelle. Pour l'OMS, il y a encore des obstacles pour les soins palliatifs.

Premièrement, la méconnaissance des responsables politiques, les professionnels de la santé et du grand public du concept des soins palliatifs. Les obstacles culturels et sociaux concernant les croyances sur la mort et la façon de mourir. Les idées erronées sur les soins palliatifs que ça concerne juste les cancéreux et les dernières semaines de la vie.

Et les idées fausses concernant la généralisation des analgésiques que ça entraîne une consommation abusive. Pour surmonter ces obstacles, l'OMS recommande d'intégrer les soins palliatifs dans tous les programmes de lutte contre les maladies, de développer l'accès aux médicaments utilisés dans les soins palliatifs en améliorant les réglementations et les systèmes de délivrance. De promouvoir l'accès aux soins palliatifs pour les enfants en collaboration avec l'UNICEF et d'encourager les initiatives de recherche dans ce domaine.

En Maroc, ça a commencé il y a quelques années avec la mise en place de 5 unités de soins palliatifs dans 5 régions Rabat-Salé-Kénitra, Casablanca, Fes-Meknes, l'Orientale et la région de Marrakech-Safi. A la région de Marrakech-Safi, cette unité a été mise en place en 2016 avec 9 chambres doubles comportant 18 lits, un hôpital 2 jours et avec un personnel comportant 2 médecins et 8 infirmiers. Et une équipe mobile de soins palliatifs qui contient un médecin, une infirmière et un psychologue.

Et puis en 2018, la publication du guide des soins palliatifs pour les patients atteints de cancer au Maroc. Les malades candidats aux soins palliatifs sont les patients atteints de maladies graves, les personnes dont la vie prend fin dans le grand âge et les proches des patients. Selon l'OMS, les malades concernés par les soins palliatifs sont les patients ayant des maladies cardiovasculaires dans 38,5%, ayant des cancers dans 34%, ayant des maladies respiratoires chroniques dans 10%, ayant le sida dans 6% et ayant le diabète dans 4,6%.

En plus d'autres maladies telles que l'insuffisance rénale chronique terminale, les maladies hépatiques chroniques, des maladies neurologiques telles que la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson et la démence. En plus de la poléatrie de Rheumatoïde, les anomalies congénitales et la tuberculose pharmacoresistante. Les soins palliatifs peuvent avoir lieu à domicile, dans les unités de soins palliatifs, dans les établissements de santé de cours moyens au plan séjour et dans les structures destinées aux personnes âgées.

Pour la formulation des objectifs de soins, en tenant compte du bénéfice-risque, du désir du patient et ses objectifs, il faut faire intervenir la famille, l'équipe soignante et bien sûr le malade selon ses désirs, ses objectifs, les symptômes qu'il présente, le stade de sa maladie, les options thérapeutiques disponibles et la proximité de la mort. Les structures des soins palliatifs en Maroc comprennent les unités de soins palliatifs qui sont rattachées aux centres d'oncologie régionaux, les lits identifiés de soins palliatifs qui sont dans les CHP ou les CHR, les centres hospitaliers régionaux ou provinciaux, l'équipe mobile de soins palliatifs qui est rattachée aux unités de soins palliatifs et en dernier, les centres de santé qui visent à prendre en charge les malades dans les zones éloignées. Les unités de soins palliatifs ont une triple mission de soins, de formation et de recherche.

Elles sont liées aux centres régionales d'oncologie et sont des structures de référence et de recours et de coordination avec les équipes mobiles de soins palliatifs et les lits identifiés de soins palliatifs. On trouve des lits d'hospitalisation à l'hôpital du jour et une consultation externe. L'objectif est de prendre en charge les malades compliqués avec des symptômes non contrôlés pour une durée limitée et elles visent aussi à accompagner les malades et leurs proches.

Les lits identifiés de soins palliatifs, on les trouve dans un service d'un centre hospitalier provincial ou régional et ce service n'est pas exclusivement dédié aux soins palliatifs. On trouve des médecins et des infirmiers formés en soins palliatifs qui assurent une prise en charge de proximité des malades référés par les équipes mobiles de soins palliatifs et en accompagnant aussi les proches des malades. Les équipes mobiles de soins palliatifs ont comme objectif prendre en charge les patients référés des unités de soins palliatifs à domicile, conseiller et soutenir les patients et leurs proches, réaliser des enquêtes, identifier les besoins des patients et leurs proches, assurer le suivi des patients.

On trouve un responsable qui est un médecin, on trouve aussi d'autres membres, d'autres médecins et des infirmiers. On peut intégrer aussi un assistant social, un psychologue, un

kinésithérapeute, une diététicienne ou un assistant religieux en cas de besoin. L'équipe mobile de soins palliatifs doit bénéficier d'une formation continue en soins palliatifs.

On trouve aussi des centres de santé qui sont désignés par province pour assurer des soins palliatifs généraux. On trouve un médecin et un infirmier formés dans ce sens qui assurent la prise en charge et l'accompagnement dans les zones éloignées en accompagnant les patients en phase terminale, en ambulatoire ou à domicile si besoin, avec l'aide et l'appui des communes, des autorités locales et des ONG. Les principaux soins sont les soins de bouche, les soins de corps, prévention et traitement des escars, prévention et traitement de la douleur, prévention de l'arrêt d'heure et des contractures musculaires, diagnostic et traitement des symptômes spécifiques.

Les soins palliatifs, c'est une tâche qui est lourde, où le médecin n'est plus le maître, c'est le malade qui a la parole et la mort le dernier mot. Les soins palliatifs, c'est accompagner quelqu'un, ce n'est pas le précéder, lui indiquer la route, lui imposer un itinéraire, ni même connaître la direction qu'il va prendre. C'est marcher à ses côtés en le laissant libre de choisir son chemin et le rythme de son pas.

Je vous remercie pour votre attention.